

Chalmers: 자가면역 질환의 구강 검진 단서

Clues to Autoimmune Disease on Oral Exam — 한국어 번역

발표자: Dr. Mary Ellen Chalmers (기능의학 기반 치과의사, Santa Rosa, California)

자가면역 의심 시 구강 임상 검진 포인트

안녕하세요, 저는 기능의학 기반 치과의사 Dr. Mary Ellen Chalmers입니다. 캘리포니아 산타로사에서 일반 치의학, 구강 내과, 구강 안면 통증을 진료하고 있습니다. 자가면역 질환이 의심될 때 임상가가 무엇을 찾아야 하는지 설명하겠습니다. 자가면역 환자를 검진할 때 저는 주로 혀, 구강 점막, 타액에 집중합니다.

1. 혀 검진

자가면역 질환을 시사하는 혀 소견:

- 위축성 설염(Atrophic Glossitis)
- 혀 측면의 가리비 모양(Scalloping on lateral borders)
- 혀 등면의 균열(Fissures on dorsal surface)
- 지도상 혀(Geographic tongue / Apache geographic tongue)

감별 진단:

- 셀리악병(Celiac Disease)
- 치과 수복 재료 문제 — 특히 혼합 금속 존재 시 과민·알레르기 반응
- 구강 위생 제품(치솔질, 치약 등)에 대한 민감성·알레르기

2. 구강 점막 검진

자가면역을 시사하는 소견:

- 구강 궤양(Oral ulcers)
- 적색 반점(Red patches)
- 백색 반점(White patches)

위 3가지 소견은 볼 점막(buccal mucosa) 또는 입술 안쪽에서 나타날 수 있으며, 일측성 또는 양측성으로 발생합니다.

중요한 구분:

- 일측성 소견: '박리성 치은염(Desquamative Gingivitis)' — 자가면역보다 자극에 의한 경우가 많음
- 양측성 구강 편평태선(Oral Lichen Planus): 자가면역 질환 — 일부 환자에서 암전 병변 가능성
- 구강 수포성 자가면역 질환: 천포창(Pemphigus), 유천포창(Pemphigoid) 가능성 고려
- ★ 구강 궤양 또는 적/백색 반점 발견 시 반드시 조직검사 의뢰!

감별 진단:

- 셀리악병, 치과 수복 재료 알레르기/과민(혼합 금속), 구강 위생 제품 반응

3. 타액 분비 검사

검사 방법:

볼을 젖히고, 2×2 거즈로 이하선관(Parotid Duct)을 닦아 건조시킵니다. 정상 타액 분비 시: 즉시 타액이 이하선관 표면에 흘러나옵니다. 지연 시: 타액 분비 감소(Hyposalivation) 또는 구강건조증(Xerostomia) 의심.

타액 분비 감소의 원인과 대처:

- 약물이 타액 기능 손상의 흔한 원인
- 셀리악병, 치과 수복 재료 알레르기, 구강 장치 알레르기 조기 확인
- ★ 임상 사례: BPA-BPS-프탈레이트-글루텐 함유 아크릴 야간 마우스가드를 생체적합 장치로 교체 후 타액선 기능 정상 회복 사례 다수

4. 자가면역 환자의 근관 치료 감염

2021년 Journal of Clinical Medicine에 게재된 체계적 문헌 고찰에서 자가면역 환자가 대조군보다 치근단 치주염(Apical Periodontitis, 지속적 근관 감염)의 발생률이 높다는 것이 밝혀졌습니다.

임상적 의미:

자가면역 환자는 뼈 치유에 어려움이 있어, 근관 치료가 필요한 경우 발치 후 임플란트 또는 브릿지를 선택하는 것이 더 나을 수 있습니다.

결론

구강에서 자가면역 증상을 인식하는 것은 종종 간과되는 근본 원인을 찾는 데 매우 도움이 됩니다. 치과의사가 전신 건강의 중요한 단서를 제공할 수 있습니다.